

肿瘤 (Tumor) 考点总结

来源: 第十一章 肿瘤.pdf, 共13页

一、核心考点概述

肿瘤的诊断五级体系（临床→实验室→影像学→病理→分子）、TNM 分期是必考重点。实体瘤治疗原则（不切割、整块切除、无瘤技术）及外科手术分类（预防性/诊断性/根治性/姑息性）为常考内容。常见体表肿瘤与囊肿的鉴别诊断是临床考题高频点。

二、重点概念与定义

- **肿瘤 (tumor)**: 机体细胞在各种始动与促进因素作用下产生的增生与异常分化所形成的新生物，不因病因消除而停止增生，不受正常生理调节 [P1]
- **实体瘤 (solid tumor)**: 绝大多数肿瘤以肿块形式出现 [P1]
- **恶病质**: 恶性肿瘤晚期全身衰竭表现，消化道肿瘤者可较早发生 [P1]
- **肿瘤标志物 (tumor marker)**: 肿瘤细胞产生的分布在血液、分泌物、排泄物中的酶、糖蛋白、激素、胚胎性抗原或代谢产物。大多数在正常与恶性组织间仅有量的差别，特异度较低 [P2]
- **TNM 分期法**: 国际抗癌联盟提出，T = 原发性肿瘤 (tumor)，N = 淋巴结 (lymph node)，M = 远处转移 (metastasis)。数字0~4表示发展程度，1低4高，0为无 [P4]
- **不切割原则**: 手术中不直接切割癌肿组织，由四周向中央解剖 [P5]
- **整块切除原则 (en bloc resection)**: 原发病灶和所属区域淋巴结作连续性整块切除 [P5]
- **无瘤技术原则 (no-touch)**: 手术中任何操作均不接触肿瘤本身 [P5]
- **R0/R1/R2 手术**: R0=肿瘤完全切除；R1=大体切除但镜下切缘阳性；R2=肉眼可见残留 [P5-6]
- **减瘤手术 (减量手术)**: 肿瘤体积大无法根治，作原发灶或转移灶部分切除，术后以非手术治疗控制残留 [P6]
- **三级预防**: 一级=病因预防；二级=早发现早诊断早治疗；三级=临床治疗与康复姑息 [P9-10]

三、关键公式与判据

- **TNM 分期示例 (乳腺癌)** [P4]:

- 0期 = TisN0M0
- I期 = T1N0M0
- IIA期 = T0~1N1M0, T2N0M0
- IIB期 = T2N1M0, T3N0M0
- IIIA期 = T0~2N2M0, T3N1~2M0
- IIIB期 = T4N0~2M0
- IIIC期 = T0~4N3M0
- IV期 = 任何含M1的T、N组合
- **肝癌肝移植米兰标准** [P7]: 单个肿瘤直径 $\leq 5\text{cm}$, 或肿瘤数目 < 3 个且最大直径 $\leq 3\text{cm}$, 无大血管侵犯、淋巴结或肝外转移
- **皮肤恶性肿瘤切除范围**: 边缘3~5cm, 深达肌膜一并切除 [P5]
- **黑色素瘤 ABCD 标准** [P11]:
 - A = 形态不对称 (Asymmetry)
 - B = 边界不规则 (Border irregularity)
 - C = 颜色不均匀 (Color variegation)
 - D = 直径 $> 6\text{mm}$ (Diameter)
- **随访制度**: 治疗后2年内每3个月一次 $\rightarrow$ 5年内每半年一次 $\rightarrow$ 5年后每年一次终身 [P10]

四、分类/分型/分期

4.1 肿瘤诊断五级体系 [P1-4]

级别	方法	要点
第一级	临床诊断	局部表现 (肿块、疼痛、溃疡、出血、梗阻、转移症状) + 全身症状
第二级	实验室诊断	常规检查、血清学(肿瘤标志物)、流式细胞术(FCM)
第三级	影像学+内镜	X线/超声/CT/MRI/PET + 各种内镜
第四级	病理诊断	最可靠的确诊方法 , 包括活检和细胞学检查
第五级	分子病理诊断	免疫组化、基因检测(PCR/FISH/测序)、液体活检

4.2 活体组织检查分类 [P4]

类型	方法	适用范围
穿刺活检	专用针头局麻下获取	皮下软组织、实体肿块（乳腺、甲状腺、肺、肝等）
钳取活检	内镜下夹取	体表或腔道黏膜肿瘤
切取活检	切取小块病变组织	病变太大，手术无法完全切除时
切除活检	肿块+部分正常组织完整切除	良性可同时达到治疗目的

4.3 化疗分类 [P6]

类型	目的
根治性化疗	针对可治愈的敏感肿瘤（急性淋巴细胞白血病、恶性淋巴瘤、睾丸癌、绒癌）
辅助化疗	根治性手术/放疗后，杀灭微转移灶
新辅助化疗	术前化疗，缩小肿瘤增加切除率
姑息性化疗	晚期延长生命、减轻痛苦

4.4 肿瘤外科手术分类 [P5-6]

- **预防性手术**：治疗癌前病变（如隐睾复位术、家族性结肠息肉病预防性结肠切除）
- **诊断性手术**：切取活检、切除活检等
- **根治性手术**：瘤切除术（良性）、广泛切除术（软组织肉瘤，切缘3~5cm）、根治术及扩大根治术
- **姑息性手术**：缓解症状（如胃癌出血行姑息性胃大部切除、直肠癌梗阻行结肠造口）
- **复发/转移灶手术**：适用于原发灶已控制且仅有单个转移灶
- **重建和康复手术**：修复根治术造成的解剖缺陷

4.5 体表肿瘤与囊肿分类 [P10-13]

类别	关键特征	恶变风险
皮肤乳头状瘤 (skin papilloma)	表皮乳头样增生，向表皮下伸延	易恶变为皮肤癌
乳头状疣	非真性肿瘤，病毒所致，基底不向表皮下伸延	可自行脱落
老年性色素疣	黑色斑块，基底平整	

类别	关键特征	恶变风险
		扩大增高达出血破溃可癌变
皮肤基底细胞癌	浸润生长，少有血道/淋巴道转移，鼠咬状溃疡边缘	低度恶性，放疗敏感
鳞状细胞癌	菜花状，易出血感染恶臭，淋巴转移	手术治疗为主
黑色素瘤 (melanoma)	高度恶性，ABCD标准 → 广泛切除	极高，不主张截肢

4.6 痣的分型 [P11]

类型	位置	恶变风险
皮内痣	表皮下、真皮层，高出皮面，可有汗毛	少见恶变
交界痣	基底细胞层，扁平，色素深	易受激惹恶变 ，多位于手足
混合痣	皮内痣+交界痣同时存在	警惕色素加深、变大、瘙痒疼痛

4.7 血管瘤分类 [P12-13]

类型	特征	治疗
毛细血管瘤 (capillary hemangioma)	婴儿多见，1年内可自行停止生长或消退	切除/冷冻/32P敷贴/泼尼松
海绵状血管瘤 (cavernous hemangioma)	皮下组织，青紫色，可压缩	手术切除，术前血管造影
蔓状血管瘤 (hemangioma racemosum)	粗大迂曲血管，可侵及骨	手术切除，充分备血

4.8 囊肿分类 [P13]

类型	特征
皮样囊肿 (dermoid cyst)	囊性畸胎瘤，颅骨骨缝处，可与颅内交通
皮脂腺囊肿 (sebaceous cyst)	非真性肿瘤 ，潴留性囊肿，小黑点开口，"豆渣物"，易感染奇臭
表皮样囊肿 (epidermoid cyst)	外伤致表皮基底细胞进入皮下，角化鳞屑
腱鞘/滑液囊肿 (synovial cyst)	非真性肿瘤 ，手腕足背，慢性劳损，治疗后易复发

五、鉴别诊断/对比

- **良性 vs 恶性肿瘤** [P1-2]:
 - 良性：病程长，有包膜，质地接近相应组织，边界清，活动度好
 - 恶性：病程短，多无包膜，质硬，表面血管丰富/温度高，边界不清，固定，可有坏死液化溃疡出血
- **皮内痣 vs 交界痣** [P11]: 皮内痣高出皮面、有汗毛、少恶变；交界痣扁平、色素深、手足多见、易恶变
- **基底细胞癌 vs 鳞状细胞癌** [P11]: 前者发展慢、少转移、放疗敏感；后者易溃疡、菜花状、淋巴转移、手术为主
- **皮脂腺囊肿 vs 皮样囊肿 vs 表皮样囊肿** [P13]: 皮脂腺囊肿有黑点开口、豆渣物；皮样囊肿为畸胎瘤、颅骨缝；表皮样囊肿与外伤相关

六、易错点与技巧

- **易错**: TNM 分期中 Tis 指原位癌 $\neq$ T1。临床分期 cTNM $\neq$ 病理分期 pTNM [P4]
- **易错**: 肿瘤标志物"不是"确诊手段——**病理诊断才是肿瘤确诊最可靠的方法** [P4]
- **易错**: 活检有促使恶性肿瘤扩散的潜在可能，应严格掌握适应证 [P4]
- **易错**: 根治术的"根治"针对切除范围而言，术后仍有复发率；其他术式也有一定治愈率 [P5]
- **易错**: 黑色素瘤禁忌不完整切除或化学烧灼；冷冻电灼无病理诊断 [P11]
- **易错**: 一级预防=病因预防（不是早诊）；二级预防=三早（早发现、早诊断、早治疗）；三级预防=康复姑息 [P9-10]
- **记忆技巧**: ABCD 黑色素瘤筛查 = Asymmetry, Border, Color, Diameter
- **记忆技巧**: TNM 数字记忆——数字越大越严重，Tis（原位） $<$ T1 $<$ T2 $<$ T3 $<$ T4, N0 $<$ N1 $<$ N2 $<$ N3, M0 $<$ M1
- **易错**: 1/3 可预防 + 1/3 可早诊治愈 + 1/3 可减轻痛苦——国际抗癌联盟三级预防的理论基础 [P9]

七、考点速记

- 我国最常见恶性肿瘤依次：肺癌 $>$ 结直肠癌 $>$ 胃癌 $>$ 肝癌 $>$ 女性乳腺癌 [P1]
- 儿童肿瘤多为胚胎性肿瘤/白血病；青少年多为肉瘤；癌多发生于中年以上 [P2]

- 肿瘤标志物酶学：ALP↑=肝癌/骨肉瘤；酸性磷酸酶↑=前列腺癌；LDH↑=肝癌/恶性淋巴瘤 [P2]
- 胚胎抗原：CEA=结肠癌/胃癌/肺癌/乳腺癌（大肠癌术后监测复发）；AFP=肝癌/恶性畸胎瘤（普查用） [P2-3]
- VCA-IgA 抗体对鼻咽癌特异，阳性率约90% [P3]
- PET 用 18F-FDG，诊断率达90%左右 [P3]
- 肿瘤治疗：Ⅰ期=手术为主；Ⅱ期=局部治疗+辅助化疗；Ⅲ期=综合治疗；Ⅳ期=全身治疗为主 [P5]
- 化疗可根治的肿瘤：急性淋巴细胞白血病、恶性淋巴瘤、睾丸癌、绒癌 [P6]
- 免疫检查点抑制剂：CTLA-4 抑制剂、PD-1/PD-L1 抑制剂、LAG3 抑制剂 [P7]
- 放疗首选根治手段：鼻咽癌（单纯放疗）、肛管癌（同步放化疗） [P8]
- 脂肪瘤：分叶状、质软、假囊性感、无痛；深部者可恶变 [P11]
- 神经鞘瘤中央型：沿神经纵行切开包膜内剥离，避免切断神经 [P12]
- 纤维黄色瘤：褐色咖啡色，直径<1cm，增大→疑纤维肉瘤变 [P11]
- 隆突性皮肤纤维肉瘤：低度恶性，假包膜，切除后极易局部复发 [P11]
- 带状纤维瘤：非真性肿瘤，无明显包膜，应完整切除 [P11]